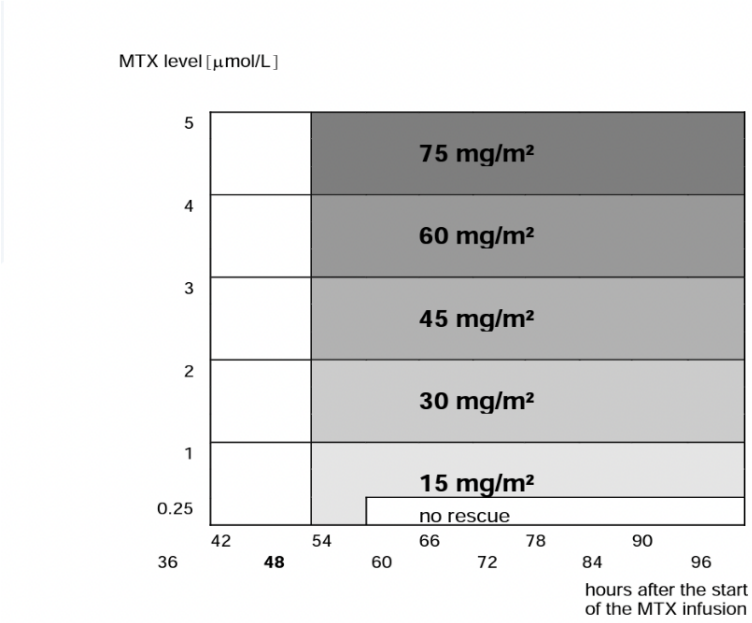
Quadro de Quimioterápicos — Categoria, Ação, Toxicidade e Orientações

Categoria	Ação	Toxicidade	Classe	Quimioterápicos	Observação
Alquilantes	Todo o ciclo celular (exceto mitose)	Mielossupressão Nefrotoxicidade Tubulopatia	Mostardas nitrogenadas	Ciclofosfamida (CTX) Ifosfamida (IFO)	Fazer expansão antes e manter HV em Y. Fazer Mesna conforme a prescrição de quimioterapia para evitar cistite hemorrágica (principal complicação em altas doses).
			Metilaminas	Melfalano	
			Alquilsulfonatos	Bussulfano	
			Triazenos	Temozolamida	
			Complexos platina	Cisplatina (CDDP) Carboplatina (CBDCA)	Carboplatina: expansão com 1000 ml/m^2 e manter hiper-hidratação. Cisplatina: expansão com 1000 ml/m^2 e hiper-hidratação com todos os eletrólitos (Na, K, Ca e Mg); controle hídrico rigoroso.
Antimetabólitos	Inibe dihidrofolato redutase	Insuficiência renal PRES	Análogos do ácido fólico	Metotrexate (MTX)	Manter hiperhidratação 3000 ml/m^2/dia (SG5% 500 ml + Bicarbonato de sódio 8,4% 20 ml). Manter pH urinário >6,5 e <8, ajustando a HV conforme. Dosar nível sérico na hora 42 (junto U, Cr, TGO, TGP, bilirrubina). Iniciar resgate com ácido folínico na hora 42 e manter até MTX < 0,25, conforme gráfico de resgate. Não correr no mesmo acesso que reposição de cálcio (precipita com bicarbonato). Atenção se níveis alterados com função renal, hepática, mucosite e colite.
		Mielossupressão	Análogos da purina	Mercaptopurina (6-MP) Fludarabina Cladribina (2-CDA)	Mercaptopurina: VO; jejum 2h antes e 2h após a ingestão; não ingerir com leite nem ter leite na refeição mais próxima.
		Mielossupressão Mucosite	Análogos da pirimidina	5-fluoracil Gencitabina Citarabina (ARAC)	Citarabina: não precisa de expansão nem hiper-hidratação. Doses >1g/m^2: risco de conjuntivite actínica — colírio de dexametasona 1h antes da 1ª dose, manter 6/6h até 24h após a última dose. Doses altas podem causar hipertermia.
Antibióticos		Cardiotoxicidade	Antraciclinas	Daunorrubicina (DAUNO) Doxorrubicina (DOXO) Idarrubicina (IDA) Mitoxantrona (MTZ)	Infusão lenta diminui cardiotoxicidade. Precisa de expansão pré-QT. Vesicante!!! Pode causar disfunção cardíaca.
		Toxicidade Pulmonar	Streptomyces	Bleomicina	
			Streptomyces	Actinomicina (AcTD)	
Inibidores Mitóticos	Impedem formação do fuso mitótico	Constipação Neuropatia periférica íleo paralítico	Alcalóides da vinca	Vincristina (VCR) Vinorelbina	Vincristina: vesicante, muito cuidado com acesso periférico; não precisa de expansão.
	Impedem divisão do fuso mitótico	Lesão de pele Anafilaxia	Tepanósidos	Paclitaxel Docetaxel	Pré-medicação com difenidramina.
Inibidores topoisomerases	Inibe topoisomerase tipo I	Diarreia	Tipo I	Irinotecano Topotecano	
	Inibe topoisomerase tipo II	Mielossupressão	Tipo II	Etoposide (VP-16) Teniposide (VM-26)	Indução de 2ª neoplasia. Não precisa expansão nem hiper-hidratação. Controle rigoroso da PA de 15/15min durante a infusão (risco de hipotensão).

Categoria	Ação	Toxicidade	Classe	Quimioterápicos	Observação
Miscelânea	Derivado da E.coli	Hipofibrinogenemia Pancreatite Anafilaxia Diabetes	Enzima	L-asparaginase	Colher controles a cada 2 doses (glicemia jejum, amilase e fibrinogênio). Vias: IM e EV. Pode alterar fibrinogênio. Relação com pancreatite.
	Diferenciação celular		Diferenciador	ATRA (ácido trans-retinóico)	Deve ser ingerido junto com alimento.
Corticosteroides		Fácies cushingóide Alteração de humor Muita fome	Corticosteroide	Dexametasona Prednisona	Vias: VO, pode ser EV se VO indisponível.
Terapia alvo		Diminuição IgG	AntiCD20	Rituximab	Fazer gamaglobulina se IgG < 400. Via EV. Medicação anti-histamínica pré: difenidramina ou hidrocortisona com loratadina; pode fazer paracetamol. Precisa de hidratação junto. Costuma correr em 6h.
		Síndrome de liberação de citocinas Toxicidade cerebral (convulsão)	Biespecífico anti-CD19/CD3	Blinatumomabe	Via EV (já existe estudo para SC). Pré-medicação: Dexametasona 6-12h e 30min antes do início. Infusão contínua de 28 dias (7 dias iniciais com dose menor). Via exclusiva: acesso central, PICC ou cateter implantado. Trocar a bolsa a cada 24h até 96h.
			Anticorpo conjugado anti-CD30	Brentuximabe	Via EV. Pré-medicação: difenidramina, dexametasona e paracetamol. Infusão de 30 minutos.

Resgate com ácido folínico para metotrexato (1g/m^2/36h)



Esquema de resgate com ácido folínico para Metotrexate (1 g/m^2/36h), referente à orientação de dosagem descrita na linha de Antimetabólitos / Metotrexate (MTX) do quadro acima.